Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Olinda

AV PAN NORDESTINA, S/N, Km 4, Vila Popular, OLINDA - PE - CEP: 53010-210

Processo nº **0000773-19.2021.8.17.2990**

AUTORA: GISELLE KARINA CHAGAS DE CARVALHO

RÉ: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos, examinados, etc.

GISELLE KARINA CHAGAS DE CARVALHO, devidamente qualificada na petição inicial, ingressou com a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,** em face da **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**, também qualificada, aduzindo, em apertada síntese, o seguinte:

1) Que, fazendo o acompanhamento médico de seu período gestacional, descobriu, por meio de exames, ser portadora de *MTHFR heterozigoto*, enzima associada ao desencadeamento da doença denominada *trombofilia*;

2) Aduz que tal condição constitui risco à sua gravidez, ante a possibilidade de tal patologia desenvolver-se e ocasionar parto prematuro ou abortamento;

3) Que, diante do seu quadro de saúde, a médica responsável por seu atendimento prescreveu o medicamento *Clexane*, a ser ministrado na dosagem recomendada;

4) Aduz, todavia, que a promovida negou a cobertura do fármaco, sob a justificativa de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela ANS.

Ancorando-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Substantiva, pugnou pela concessão de tutela de urgência, compelindo-se a requerida a custear o medicamento. No mérito, requereu a confirmação do provimento antecipatório e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a reembolsar-lhe os custos do medicamento em apreço, suportado com recursos próprios desde a negativa.

Dentre os documentos que instruíram a petição inicial vieram cópia da carteira de identificação da autora junto ao plano de saúde operado pela demandada; exame e parecer médico, dando conta de seu estado clínico e da prescrição do medicamento em questão; notas fiscais de compra do fármaco; entre outros.

Tutela antecipada deferida no ID 74682571, onde também foi ordenada a citação da requerida.

Defesa, na modalidade contestação, apresentada pela ré no ID 75970467, argumentando restar ausente previsão legal e contratual para a cobertura do medicamento perquirido. Enfatiza que o artigo 10, inciso, VI, da Lei dos Planos de Saúde, exclui da cobertura obrigatória medicamentos de uso domiciliar, salvo antineoplásicos, pugnando, desta feita, pela improcedência dos pedidos.

Intimada, a autora não apresentou réplica.

Oportunizada a produção de outras provas, a partes quedaram-se silentes.

Eis o relato do necessário. Decido.

Não foram suscitadas preliminares. Passo portanto, diretamente ao mérito. Pois bem.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, alterou a sua jurisprudência quanto ao rol de procedimentos e eventos de saúde estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) ser taxativo ou não.

Até então prevalecia na jurisprudência do STJ que o mencionado rol era meramente exemplificativo (*v. g.* AgInt no Resp 1.912.263/SP, j. em 12/04/2021, e; AgInt no REsp: 1.829.583/SP, j. em 22/06/2020), entendimento perfilhado por este Juízo, na medida em que os atos administrativos da agência reguladora não podem limitar ou restringir o alcance da Lei que disciplina a matéria, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Ademais, a própria Lei da ANS é clara ao preconizar que o dito rol constitui apenas uma "<u>referência básica</u>" (art. 4°, III, da Lei n° 9.961/2000).

Todavia, a partir de precedente isolado da Quarta Turma (REsp 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 10/12/2019, DJe 20/02/2020), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça foi instada a dirimir a divergência instaurada, fixando, porém, entendimento contrário ao que então prevalecida naquele Sodalício.

Assim, no dia 08/06/2022, a Corte Superior, ao julgar os EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu as seguintes teses:

> 1. **<u>O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo</u>**;
>
> 2. **<u>A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol</u>**;
>
> 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

> 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva *ad causam* da ANS.

Preocupado com a segurança jurídica, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo 3°, do artigo 927, previu a possibilidade de modulação dos efeitos de decisão que altere jurisprudência dominante dos tribunais sobranceiros. Entretanto, o STJ foi silente na aplicação de tal dispositivo.

Desta feita, penso que os julgamentos que envolvam a matéria, ainda que a controvérsia se reporte a fatos que precedam às decisões alhures, devem ser realizados à luz do novo entendimento firmado pela Corte Superior, a qual detém a competência constitucional de dar a última palavra em se tratando de interpretação da legislação ordinária (art. 105, III, c, da CF).

Feita esta digressão, passo a analisar o caso concreto.

De início, ao contrário do que sustenta a parte requerida, não é possível considerar o fármaco prescrito à autora medicamento de uso domiciliar, diante de sua complexa administração e da linguagem técnica da bula acerca do modo de ministrá-lo, sendo evidente a necessidade de o paciente receber auxílio profissional.

A propósito, observe-se o que diz a bula do medicamento[1], quanto ao seu modo de utilização (pp. 6 e 7):

> "2. *A injeção deve ser administrada por injeção subcutânea profunda, no tecido subcutâneo da parede abdominal, com o paciente deitado ou sentado em posição confortável, alternando entre os lados esquerdo e direito a cada aplicação. 3. A agulha deve ser introduzida perpendicularmente na espessura de uma prega cutânea feita entre os dedos polegar e indicador. A prega deve ser mantida durante todo o período da injeção (figura 2). Não esfregue o local da injeção após a administração.*"

Nota-se, claramente, que a autoinjeção, se levada à efeito pelo paciente, é deveras temerária, em função da grande possibilidade de erro na aplicação, podendo resultar eventos/danos adversos, ou mesmo prejudicar a absorção da substância pelo organismo e, consequentemente, a eficácia do tratamento.

Com efeito, trata-se de medicamento que deve ser ministrado em sede ambulatorial, não se subsumindo à hipótese de exclusão de cobertura prevista no inciso VI, do artigo 10, da Lei n° 9.656/1998.

Neste sentido, veja-se trecho da ementa do proficiente julgado a seguir: (grifos nossos)

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. **RECUSA DO PLANO DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40 MG (CLEXANE) EM FAVOR DA AUTORA, ACOMETIDA POR TROMBOFILIA E NA 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO.** DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA O MEDICAMENTO.RECURSO DA DEMANDADA. [...]. 3. Necessidade urgente de tratamento ininterrupto da agravada com medicamento ENOXAPARINA 40 mg (Clexane), durante a gestação e puerpério, considerando o risco de interrupção da gravidez, bem como o histórico de abortamento da recorrida, conforme laudo médico, cujo fornecimento foi negado pela ré/agravante, sob o argumento de não constar no rol da ANS e não ser indicado ao tratamento prescrito 4. O artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, e o artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa da ANS 465/2021, dispõem sobre os procedimentos e medicamentos que os planos de saúde não são obrigados a fornecer, ao passo que o artigo 12, I, c e II, g, da Lei nº 9.656/1998, impõe como obrigação do plano de saúde a cobertura de antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral. 5. Orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.692.938/SP, no sentido de que, em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório. **6. O medicamento indicado para tratamento da moléstia não é de simples uso domiciliar, tratando-se de remédio injetável, administrado por via subcutânea, aproximando-se de tratamento ambulatorial ou clínico a ensejar a obrigatoriedade do fornecimento. Precedentes deste TJRJ**[...]. 13. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ - AI n° 0024403-62.2022.8.17.0000, Rel. Des. Marianna Fux, j. em 02/06/2022, Publicação: 03/06/2022)

Noutro giro, conquanto o STJ tenha assentado que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS é taxativo, deixou expresso, por outro lado, que o plano de saúde só não seria obrigado a custear tratamento não constante no sobredito rol se existisse **outro procedimento eficaz, efetivo e seguro nele já incorporado.**

Nessa toada, competiria à operadora do plano de saúde comprovar a existência de substituto terapêutico previsto no rol, o que nada tem a ver com inversão do ônus da prova, mas sim da incumbência da parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, na esteira do disposto no artigo 373, II, do CPC/15.

No caso vertente, entretanto, a demandada não se desincumbiu desse ônus, limitando-se, na contestação, a reproduzir a justificativa apresentada à paciente, por ocasião da negativa.

Ora, de acordo com a Tese n° 2 fixada pelo C. STJ nos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, este tipo de negativa, como dito, é condicionada à existência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, que possa ser utilizado contra a patologia diagnosticada no usuário do plano de saúde.

De outra banda, na esteira do entendimento firmado pelo STJ no sobredito julgado (Tese n° 4), inexistindo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, capazes de substituir eficazmente o tratamento requestado, deve haver a cobertura, satisfeitos os seguintes requisitos:

> *(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar;*
>
> *(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;*
>
> *(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e*
>
> *(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.*

In casu, reputo satisfeitos os pressupostos acima, uma vez que:

a) não há notícia de que o dito remédio teve a inclusão no rol expressamente negada pela ANS (item *i*);

b) a bula do medicamento encontra-se aprovada pela Anvisa desde 09/10/2000, sob o número 113000276, processo n° 25000.017007/88, prevendo indicação para profilaxia do *tromboembolismo venoso*, já tendo passado, portanto, pelos estudos necessários à comprovação de sua eficácia e segurança (itens *ii* e *iii*);

c) a questão não chega a ultrapassar o interesse subjetivo das partes, motivo pelo qual entendo ser desnecessária a ampliação da discussão (item *iv*), sob pena de prejudicar a razoável duração do processo.

Com efeito, verifica-se que não há guarida que justifique a operadora do plano de saúde se escusar de autorizar o tratamento prescrito pelo profissional de saúde para doença de cobertura obrigatória (art. 10, *caput*, da Lei n° 9.656/98).

Nesse diapasão, dispõe o artigo 422 da Lei Substantiva:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e **boa-fé**. (GN)

Conforme os ensinamentos do preclaro jurista Miguel Reale que "*a boa-fé não constitui um imperativo ético abstrato, mas sim uma norma que condiciona e legitima toda a experiência jurídica, desde a interpretação dos mandamentos legais e das cláusulas contratuais até as suas últimas consequências*"[2].

Ainda de acordo com o saudoso jusfilósofo:

> *"[...] a boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. Tal conduta impõe diretrizes ao agir no tráfico negocial. [...]."* [3]

Em verdade, não basta apenas executar o contrato conforme o pactuado; deve-se cuidar que a sua execução seja levada a efeito sem intercorrências desnecessárias e inoportunas ao contratante ou mesmo a terceiros.

Para o Direito Material, a boa-fé objetiva não é empregada meramente como antônimo de má-fé, possuindo um espectro muito mais amplo, indo além da boa-fé subjetiva, que se limita apenas a aspectos relacionados à manifestação da vontade do agente.

Trata-se de uma cláusula geral estatuída como corolário da função social dos contratos, que estabelece uma regra de conduta.

Nessa linha de intelecção, a simples inobservância da boa-fé objetiva na execução da avença, se provocar dano ao contratante, ainda que exclusivamente moral, configurará ato ilícito, passível de reparação (CC, arts. 186, 187, 422 e 927).

A partir desse raciocínio, a negativa de custear o tratamento prescrito pelo médico ao paciente que contratou o plano de saúde, mediante interferência no protocolo ou procedimento escolhido para combater a enfermidade, fazendo restrições aos materiais empregados, ao método cirúrgico, ou limitando o tempo de tratamento, por exemplo, constitui abuso de direito, por violar a boa-fé objetiva, conforme preconiza o artigo 187 do Código Civil, *litteris*:

> **Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.** (GN)

Por conseguinte, uma vez prevista a cobertura para determinada doença, não pode a Operadora de Planos de Saúde se abster de custear qualquer tipo de tratamento a ela disponível ou impor restrições ao procedimento adotado pelo médico, sob pena de esvaziar o próprio objeto da cobertura, maculando a boa-fé e o equilíbrio contratual.

Insta salientar que a Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a entidade que opera planos de saúde não pode ser furtar de custear integralmente o tratamento prescrito pelo médico para doença que conte com a devida cobertura contratual. Neste sentido:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. **PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO.** FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. **1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.** [...]. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1093958/CE, Rel. Desembargador Convocado Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)
>
> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. **PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE**. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. [...]. **3. Dadas as peculiaridades do caso dos autos, é considerada abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados pelo médico para melhor tratamento da enfermidade coberta pela plano.** Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1674948/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2017, DJe 23/11/2017)
>
> [...]. **2. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde.** [...]. 4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da

> ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017)

Destarte, uma vez que a patologia (*Trombofilia* - CID D68.2) é de cobertura obrigatória, nos termos do artigo 10 da Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), deve a requerida custear o medicamento, nos termos do contrato celebrado com a parte autora.

Nesse lamiré, deve a requerida reembolsar a autora pelos valores expendidos para a aquisição do medicamento, no período compreendido entre a data da confirmação da negativa e o efetivo cumprimento da tutela antecipada deferida em seu favor no curso do presente feito, perfazendo o total de R$ 1.276,30 (mil duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos), conforme notas fiscais de ID 74644285.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a partir da dinâmica dos acontecimentos narrados na peça de ingresso, corroboradas pelas provas que integram este caderno processual, vislumbro que a promovente foi submetida a abalo psicológico que foge das condições normais do cotidiano e do tratamento médico pelo qual passou durante seu estado gravídico, considerando o temor por complicações em sua saúde ou na saúde do nascituro.

O descumprimento da avença, nestes casos, afeta sobremaneira o estado psicológico da paciente, que já se encontra em situação de fragilidade emocional, em uma ocasião na qual a mesma espera maior atenção daquele a quem confiou cuidar de sua saúde.

A propósito, vejamos o entendimento do E. STJ sobre o tema: (grifos nossos)

> AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS STF/282 E 356. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. **I. Na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é caso de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele.** [...]. (AgRG no REsp 12229872/AM, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/07/2011)

Vislumbro, pois, existente o dano moral.

Penso que a ré, como operadora de plano de saúde, tem o dever de conhecer de forma profunda as normas que regem o sistema de assistência à saúde e ter como norte de sua atividade a prevalência da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.

Aqueles que buscam o serviço de saúde na rede privada assim já o fazem exatamente para fugirem da ineficiência do sistema público. Não obstante adimplirem a exação exigida pelo Estado para custeio dos serviços públicos, reservam parte do numerário próprio, muitas vezes com o sacrifício de outras necessidades, para terem acesso ao sistema privado.

Assim, quando há um tratamento descompromissado com a efetiva prestação da assistência à saúde por parte da permissionária desse serviço público, de modo a inviabilizar o acesso pelo contratante quando este mais precisa, causa-lhe enorme frustração.

Está é a hipótese que se apresenta no caso em comento, tendo em vista que, solicitado o atendimento, a operadora ré foi recalcitrante, não se desincumbindo da obrigação contratual a que se comprometeu a prestar, malgrado receber a contraprestação mensal adimplida pela demandante.

Portanto, não é caso de mero inadimplemento contratual, mas sim de evidente dano moral.

Presentes, dessa forma, o nexo causal e a culpa da demandada, na forma prevista nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar a requerente, como forma de amenizar abalo moral por ela suportado.

É consabido que o dano moral é aquele que afeta o patrimônio intangível da pessoa. O nome, a honra, a intimidade, vida privada, a imagem perante a sociedade, são tutelados pelo Direito, de forma que o abalo que supere as condições normais do cotidiano e da vida em sociedade gera, ao seu causador, o dever de indenizar.

Com a promulgação da Carta Política de 1988, perdeu o sentido a vetusta batalha doutrinária sobre a hipótese de reparação do dano moral puro, em que pese o já majoritário reconhecimento de sua existência. Contudo, não é demais salientar, que nossa atual Carta Maior consagra, como um dos fundamentos de nosso Estado, o princípio da dignidade da pessoa humana, e, como corolário disto, assevera que são invioláveis, a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, garantida a indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação (CF, art. 5°, X).

Sabe-se, ademais, que os danos morais são aqueles que afetam o ânimo moral da vítima, submetendo-a a uma angústia acima do tolerável, cujos efeitos tanto podem irradiar em sua honra objetiva, isto é, ao conceito que a vítima possui perante os seus pares, como se limitar à sua esfera subjetiva, ou seja, aos valores íntimos que formam a sua personalidade. De uma forma ou de outra, trata-se um bem da pessoa tutelado pelo nosso ordenamento jurídico.

Sobre o tema dano moral, o grande Silvio de Salvo Venosa[4], de forma magistral comenta:

> *Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí porque aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de amenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.*

E ainda:

> *Há um duplo sentido de indenização por dano moral: ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o cunho educativo, didático ou pedagógico que essas indenizações apresentam para a sociedade.*

No que se refere ao *quantum* indenizatório, é cediço que não existe critério legal para a sua aferição, ficando a cargo da doutrina dizer quais os parâmetros de que o magistrado deve se respaldar para tal aferição, apontado os doutos do Direito os mais variados critérios, existindo, inclusive, grandes divergências.

Sobre tais critérios, observe-se a lição do professor Rizzato Nunes[5]:

> *[...] a natureza de fixação do valor indenizatório por dano moral, deve ser determinada por alguns parâmetros, tais como: a natureza específica da ofensa sofrida, a intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do consumidor, a repercussão da ofensa no meio social, a existência de dolo ou má-fé, a situação econômica do ofensor, a capacidade e possibilidade real e efetiva do ofensor voltar a praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo fato danoso, etc. [...]*

Sem embargo dos parâmetros acima, os quais, sem sombra de dúvida, devem ser levados em consideração, grande parte da doutrina e da jurisprudência apontam no sentido de que o magistrado deve-se valer dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização tenha caráter pedagógico para o(a) demandado(a), no sentido de evitar a reiteração da reprovável conduta e, ao mesmo tempo, ser capaz de amenizar/compensar o abalo moral que sofreu o ofendido, sem, no entanto, causar-lhe enriquecimento ilícito.

De outra banda, não pode o *quantum* ser demasiadamente ínfimo, nem tampouco absurdo, não condizente com a situação econômica do ofensor.

Assim, levando em consideração os critérios acima e as peculiaridades do caso concreto, diante da situação fática e do que restou provado nos autos, fixo o *quantum* indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o fito de compensar o abalo moral sofrido pela demandante.

Conclusão:

Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES[6]** os pedidos, para:

I - CONDENAR a ré, **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, **GISELLE KARINA CHAGAS DE CARVALHO**, a título de indenização por danos morais.

Sobre o valor acima incidirá atualização monetária, de acordo com a tabela ENCOGE, a contar desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406), estes contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

II - CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 1.276,30 (mil duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos), em favor da requerente, a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizado (ENCOGE) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC), ambos contados da citação válida.

III - CONFIRMAR a tutela de urgência concedida em favor da demandante (ID 74682571), nos termos da qual a requerida deve arcar com os custos medicamento prescrito àquela, consoante estabelecido na requisição médica de ID 74644282.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, devidamente atualizadas pela tabela ENCOGE, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, corrigido monetariamente pela citada tabela, considerando a natureza da causa, o grau de zelo do causídico e o tempo despendido para o serviço, nos termos do artigo 85, § 2°, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Olinda, 08 de setembro de 2022.

Carlos Neves da Franca Neto Júnior

Juiz de Direito

---

[1] Disponível em: https://storagemv.blob.core.windows.net/pdf/clexane.pdf. Acesso: 08, set. 2022.

[2] **REALE**, Miguel. A boa-fé no Código Civil. 2003. Disponível em: < http://www.miguelreale.com.br/ >. Acesso em: 08, set. 2022.

[3] Idem.

[4]

[4] **VENOSA**, Silvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil / Silvio de Salvo Venosa – 8 ed. – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008.

[5] **NUNES**, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor / Rizzatto Nunes – 4ª ed – São Paulo: Saraiva. 2009.

[6] Súmula 326 do STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Assinado eletronicamente por: CARLOS NEVES DA FRANCA NETO JUNIOR
08/09/2022 11:43:36
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 114310927

22090811433635700000111757640

IMPRIMIR GERAR PDF